

MG-K10-SAR-001_临床研究方案修订说明

研究药物	MG-K10 人源化单抗注射液
版本及日期	修订前：V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日） 修订后：V2.1（版本日期：2025 年 09 月 19 日）

V2.1 MG-K10-SAR-001_临床研究方案关键修订内容及修订原因如下表所示：

页码/条目	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	V2.1（版本日期：2025 年 09 月 19 日）	修订原因
全文：降雨量	降雨量	天气情况	花粉浓度除降雨量影响外还受降雨形式和大风等影响
第 33 页/1.3 研究日程表- 11.过敏原筛查	Ⅲ期：筛选/导入期一种或多种过敏原血清 sIgE 检测呈阳性（包括 SAR/PAR 相关）	Ⅲ期：筛选/导入期一种或多种过敏原血清 sIgE 检测呈阳性（包括 SAR/PAR 相关）， 中心实验室检测	保证检测结果的一致性
第 33 页/1.3 研究日程表-13.肺功能测定	所有受试者均需要进行肺功能测定，记录 FEV1（占预测值百分比）的结果。 V2 时 的检测需要在随机前完成，如果患者在 V2 时 的测定值满足排除标准，将不会进行随机	所有受试者均需要进行肺功能测定，记录 FEV1（占预测值百分比）的结果。 筛选/导入期 的检测需要在随机前完成，如果患者在 筛选/导入期 的测定值满足排除标准，将不会进行随机	准确表述检测时间
第 34 页/1.3 研究日程表-19.血常规	血常规：包括白细胞计数（White blood cell count, WBC）、中性粒细胞计数（Neutrophil, NEUT#）、嗜酸性粒细胞计数（Eosinophil, EO#）、嗜碱性粒细胞计数（Basophils, BASO#）、淋巴细胞计数（Lymphocyte, LYMPH#）、红细胞计数（Red blood cell count, RBC）、血红蛋白（Hemoglobin, Hb）、血小板计数（Blood platelet, PLT）、红细胞压积（Hematocrit, HCT）；（回车键）	删除回车键	格式更改

第 35 页/1.3 研究日程表 第 72 页/正文-8.1.3 安全访视期 (W4~W12)	27.仅Ⅱ期进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分 • rTNSS/rTOSS 评估 (V6, 仅Ⅱ期); • iTNSS/iTOSS 评估 (V6, 仅Ⅱ期); • RQLQ 评估 (V6, 仅Ⅱ期)	27.Ⅲ期仅 V6 上午进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分, 之后不再进行 • rTNSS/rTOSS 评估 (V6); • iTNSS/iTOSS 评估 (V6); • RQLQ (s) 评估 (V6)	根据各地区实际花粉情况大部分受试者 V5 访视仍在花粉期内
第 35 页/1.3 研究日程表 第 73 页/正文-8.1.4 提前退出访视	28.Ⅱ期: 如果受试者在 V6 之后退出, 退出访视时不进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分; Ⅲ期: 如果受试者在 V5 之后退出, 退出访视时不进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分 • rTNSS/rTOSS 评估 (Ⅱ期 V6 后退出 not 进行评分, Ⅲ期 V5 退出后 not 进行评分); • iTNSS/iTOSS 评估 (Ⅱ期 V6 后退出 not 进行评分, Ⅲ期 V5 退出后 not 进行评分); • RQLQ 评估 (Ⅱ期 V6 后退出 not 进行评分, Ⅲ期 V5 退出后 not 进行评分);	28.Ⅱ和Ⅲ期: 如果受试者在 V6 之后退出, 退出访视时不进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分 • rTNSS/rTOSS 评估 (Ⅱ期、Ⅲ期 V6 后退出 not 进行评分); • iTNSS/iTOSS 评估 (Ⅱ期、Ⅲ期 V6 后退出 not 进行评分); • RQLQ (s) 评估 (Ⅱ期、Ⅲ期 V6 后退出 not 进行评分);	根据各地区实际花粉情况大部分受试者 V5 访视仍在花粉期内
第 55 页/5.1 入选标准-Ⅲ期入选标准	2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南 (2022 年, 修订版)》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断, 既往明确病史≥2 年, 筛选/导入期至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的 sIgE (可接受随机入组前≤1 年内的检测结果) 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准	2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南 (2022 年, 修订版)》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断, 既往明确病史≥2 年, 筛选/导入期至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的 sIgE 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准	正文与摘要保持一致

第 77 页/8.2.7 花粉监测	花粉季结束时间按照气象监测结束时间为准。		花粉季结束时间为排除天气情况（如降雨）外，监测期间的花粉计数连续 3 天 < 20 粒/1000mm² 的第一天为花粉季的结束日期。		根据研究者意见修订
第 89 页/ 9.4.4.2.1 III 期主要估计目标		伴发事件	处理策略		
		2 周内因疗效不佳提前退出研究	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，符合临床实践。		
		2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。		
		2 周内发生影响疗效评价的重大方案偏离	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。		
		伴发事件	处理策略		
		2 周内因疗效不佳提前退出研究	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。		
		2 周内因非疗效不佳提前退出研究	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。将采用多重填补对伴发事件后的数据进行填补。		
		2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。		
		2 周内使用补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。		
		2 周内使用非影响疗效评价的禁用药物/治疗	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，收集并使用数据。		

第 90 页/9.4.4.2.2 III 期次要估计目标	伴发事件及处理策略： 1. 2 周内因疗效不佳提前退出研究，采用疗法策略 2. 2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗，采用假想策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。 3. 2 周内发生影响疗效评价的重大方案偏离，采用假想策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。	伴发事件及处理策略：同主要估计目标	根据监管 EOP2 沟通交流书面反馈进行修订
第 92 页/9.4.5.2 III 期有效性分析-主要 估计目标分析	缺失数据的处理：若疗效指标缺失天数低于评估期间的 20%，则不进行填补，按照已有的评分计算均值，若超过 20%，则采用末次访视结转（LOCF）法对缺失值进行填补，具体缺失数据的处理详见统计分析计划。 敏感性分析：1) 对采用假想策略的伴发事件，相应数据采用最差结果填补法（WOCF）填补后进行敏感性分析。2) 对缺失值不进行填补，进行分析。其他更为详细的数据处理及敏感性分析，详见统计分析计划。 补充分析：基于 PPS，进行分析。	缺失数据的处理：若疗效指标缺失天数低于评估期间的 20%，则不进行填补，按照已有的评分计算均值，若超过 20%，则采用多重填补进行填补，具体缺失数据的处理详见统计分析计划。 敏感性分析：1) 对采用假想策略的伴发事件，伴发事件后的数据将采用最差结果填补法（WOCF）填补后进行敏感性分析。2) 伴发事件后的数据将采用最近一次观察结果（LOCF）填补后进行敏感性分析。 其他更为详细的数据处理及敏感性分析，详见统计分析计划。 补充分析：基于 PPS，将采用与主要分析相同的方法进行分析。	根据监管 EOP2 沟通交流书面反馈进行修订

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司
2025 年 09 月 19 日